

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем
Индикатор	Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ (ПАВ)
2. Информация об организации	
Организация	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Показатель определяется как число лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ по видам (алкоголь, наркотики), находящихся на профилактическом и динамическом учете, деленное на общее количество населения, в расчете на 100 000 человек.
Основные понятия:	Психические, поведенческие расстройства (заболевания), вызванные употреблением психоактивных веществ - группа заболеваний согласно международной классификации болезней, характеризующихся комплексом физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых употребление ПАВ начинает занимать более важное место в системе ценностей человека, чем другие формы поведения, которые ранее были более важными для пациента (SAMHSA How Stimulants Affect the Brain and Behavior/Treatment for Stimulant Use Disorders Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 33 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64333)
Обоснование и толкование	Данный показатель позволяет оценить уровень распространенности потребления психоактивных веществ среди разных групп населения страны. Используется для расчета контингентов больных алкоголизмом и наркоманиями, нуждающихся в амбулаторном и стационарном лечении. Показатель позволяет оценить число лиц, регулярно употребляющих ПАВ, а так же в процессе мониторинга оценить размер скрытого контингента потребителей, и последствия, связанные с потреблением ПАВ в стране. Оценка показателя позволяет обеспечивать национальную аудиторию информацией, которая считается необходимой для выработки политического курса и организации соответствующих услуг.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Источником являются статистические данные отчета о заболеваниях и контингентах больных психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ приложение 14 (форма 11) приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22.12.2020 года № ҚР ДСМ – 313/2020 «Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения»
Методы сбора данных	Данные формы №054/у «Статистическая карта амбулаторного пациента», утвержденная приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.10.2020 года № ҚР

	ДСМ – 175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению».
Единица измерения	В расчете на 100 000 человек.
Периодичность	Ежеквартально
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Показатель рассчитывается как общее число лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ по видам (алкоголь, наркотики), находящихся на профилактическом и динамическом учете, деленное на общее количество населения, в расчете на 100 000 человек.
Комментарии и ограничения:	В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (англ. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), разработанной под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), блок Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, содержит широкий спектр различных по тяжести и клиническим проявлениям расстройств, развитие которых всегда связано с употреблением одного или более психоактивных веществ. Идентификация психоактивного вещества должна основываться на возможно большем числе источников информации. К ним относятся данные, сообщенные самим индивидом, результаты исследования крови и других биологических жидкостей, характерные соматические и психологические признаки, клинические и поведенческие симптомы, а также другие очевидные данные, такие, как вещество, находящееся в распоряжении пациента, или информация от третьих лиц. Многие потребители наркотиков используют не один вид наркотического вещества. Основной диагноз должен быть по возможности установлен по веществу (или группе веществ), которое вызвало клинические симптомы или способствовало их появлению. В данный индикатор принято включать диагнозы, когда потребление психоактивного вещества причиняет вред здоровью, либо привело к зависимости или другим нарушениям.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Республиканского научно-практического центра психического здоровья, https://mentalcenter.kz
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по видам ПАВ, полу, возрасту, географическому положению.
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	Данные по заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ по видам (алкоголь, наркотики), на 100 000 населения РК сопоставима с данными нескольких стран СНГ (Российская Федерация, Белоруссия, Украина, Узбекистан, Киргизия и др.). В большинстве стран Европы и Америки подобный индикатор оценивается в рамках регулярных эпидемиологических исследований.

	Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) оценивает распространенность и характер употребления ПАВ среди населения в целом (взрослые или школьники) оцениваются посредством обследований, основанных на репрезентативных вероятностных выборках всего исследуемого населения. Опросы в ходе интервью основаны на самоотчетах участников о настоящем и прошлом поведении, личных характеристиках, знаниях и отношении к наркотикам или другим вопросам здоровья.
8. Ссылки и документация	https://mentalcenter.kz/ru/index.php/pages/plany-i-otchety/otchjot-o-deyatelnosti-tsentra